

**Certificats de vaccination chez le chien et le chat : fondement
immunologique, validité sanitaire et cadre réglementaire international**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Serie Technique Vol. IX - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20209567

Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resume

Objectif. Analyser le fondement immunologique des certificats de vaccination antirabique chez le chien et le chat, leur validite sanitaire internationale et les criteres determinant leur acceptation ou rejet en frontiere. **Methode.** Revue des cadres reglementaires des principales destinations internationales, des protocoles de vaccination primaire et de rappel, et des exigences d'identification et de tracabilite. **Resultats.** La validite d'un certificat ne depend pas uniquement de la date de vaccination, mais de la concordance entre puce electronique, espece, produit vaccinal approuve, schema primaire complet et fenetre temporelle exigee par le pays de destination. Une erreur dans l'un de ces elements invalide le document. **Conclusion.** La gestion correcte du certificat de vaccination est le premier maillon critique du dossier d'exportation d'animaux de compagnie et determine l'admissibilite de l'animal independamment de son statut serologique.

Mots cles: certificat de vaccination, rage, puce ISO, schema primaire, tracabilite, exportation animaux, validite documentaire

Revue du fondement immunologique de la vaccination animale, de l'articulation entre validité biologique et validité légale, des erreurs techniques fréquentes et du cadre réglementaire comparé des principales destinations d'exportation d'animaux de compagnie.

Jessica Ysabel Camacho Garcia, Vétérinaire -- CMVP 12434 -- Zoovet Travel,
Lima, Pérou | Révision : février 2026

Section 1 Le certificat de vaccination comme acte médico-documentaire

Il existe une tendance, compréhensible mais techniquement incorrecte, à considérer le certificat de vaccination comme une simple formalité administrative : un formulaire à remplir après l'administration d'un vaccin et dont la fonction est de prouver ce fait devant une autorité. Cette compréhension sous-estime la nature du document et, dans la pratique du mouvement international des animaux, est à l'origine de nombreuses erreurs aux conséquences difficiles à inverser.

Le certificat de vaccination est la formalisation documentaire d'un acte médical préventif complexe. Cet acte comporte plusieurs composantes qui doivent être respectées correctement et dans la séquence appropriée pour que le document ait une validité technique, et pas seulement formelle :

1.1 Identification non équivoque de l'animal

La première composante de l'acte médico-documentaire est l'identification de l'individu auquel le vaccin est administré. Dans le contexte du mouvement international, l'identification standard est la puce électronique conforme aux normes ISO 11784/11785, dont le numéro doit figurer sur le certificat et correspondre exactement à celui lu sur l'animal à tout point de contrôle ultérieur.

Cette concordance n'est pas une exigence bureaucratique. Elle repose sur une question technique fondamentale : comment l'autorité sanitaire de destination peut-elle vérifier que l'animal qui se trouve devant elle est bien celui qui a reçu le vaccin enregistré ? Sans identifiant permanent et univoque, cette vérification n'est pas possible. Le numéro de

puce est le fil conducteur qui relie l'individu biologique à l'ensemble de la chaîne documentaire sanitaire qui l'accompagne.

1.2 Administration correcte du vaccin

La signature du vétérinaire sur un certificat de vaccination est une déclaration technique, et non une simple paraphé de procédure. Elle implique que le professionnel confirme que : le vaccin administré correspond à l'espèce et à l'indication, le vaccin a été conservé dans des conditions appropriées de chaîne du froid, la dose et la voie d'administration étaient celles indiquées par le fabricant, l'animal se trouvait dans des conditions cliniques compatibles avec la vaccination au moment de l'acte, et le numéro de lot et la date de péremption ont été correctement enregistrés lorsque la réglementation de destination l'exige.

Chacun de ces points peut faire l'objet d'une vérification par les autorités sanitaires de destination. Un certificat qui ne peut démontrer qu'ils ont tous été respectés a une solidité documentaire limitée, quel que soit son format.

1.3 Enregistrement conforme à la réglementation en vigueur

Le même acte clinique peut produire un document valide ou invalide selon que son enregistrement respecte ou non les exigences formelles du pays de destination. Ces exigences peuvent inclure : l'utilisation d'un format officiel spécifique (numéroté, imprimé, avec code de vérification), la transcription du numéro d'habilitation ou d'inscription ordinale du vétérinaire émetteur, la signature et le cachet du vétérinaire officiel ou agréé lorsque la réglementation l'exige, ou l'inscription dans un système de registre national ou régional.

Le contenu clinique peut être impeccable et le document peut néanmoins être rejeté à la frontière si l'une de ces exigences formelles n'est pas respectée. Cette apparente paradoxe a une logique sanitaire précise : les systèmes de contrôle du mouvement des animaux sont conçus pour être vérifiables à grande échelle, et cette vérifiabilité exige une standardisation formelle, et pas seulement une exactitude clinique.

Section 2 Fondement immunologique de la vaccination animale

2.1 L'acte de vaccination et la protection : une distinction nécessaire

Vacciner un animal n'est pas synonyme de le protéger. C'est initier un processus biologique dont le résultat --la génération d'une mémoire immunologique fonctionnelle-- dépend de variables que l'acte de vaccination seul ne contrôle pas. Comprendre cette distinction est essentiel pour interpréter correctement tant la validité immunologique que la validité légale des certificats de vaccination pour l'exportation d'animaux de compagnie.

Le système immunitaire adaptatif, en reconnaissant les antigènes contenus dans un vaccin, déclenche une réponse qui inclut la prolifération et la différenciation des lymphocytes B et T spécifiques. Les lymphocytes B différenciés produisent des anticorps de classes progressivement plus efficaces (processus de maturation d'affinité), tandis qu'une sous-population des deux lignées devient des cellules mémoire à longue durée de vie. Ce sont ces cellules mémoire qui confèrent une protection réelle face à une exposition ultérieure à l'agent infectieux.

2.2 Réponse humorale et mémoire immunologique

La réponse humorale --médiée par les anticorps-- est le paramètre immunologique le plus fréquemment mesuré dans le contexte de la vaccination pour le voyage, car il est quantifiable par des épreuves sérologiques. Après une première vaccination (réponse primaire), les titres d'anticorps spécifiques apparaissent avec un délai de jours à semaines, atteignent un pic puis déclinent. Ce schéma cinétique est la base immunologique du délai d'attente minimal post-vaccinal exigé par les réglementations d'importation : l'organisme a besoin de temps pour générer une réponse mesurable.

Lors d'une revaccination (réponse secondaire ou anamnétique), les cellules mémoire préalablement générées répondent de manière plus rapide, plus intense et plus durable. Cette différence a des implications pratiques : un animal vacciné pour la première fois n'a pas la même protection immédiate qu'un animal ayant des antécédents vaccinaux, bien que les deux puissent porter un certificat de vaccination formellement valide.

Les directives de vaccination de la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) distinguent explicitement les vaccins « core » --ceux dont l'administration est recommandée à tous les animaux de l'espèce quelle que soit leur situation-- des vaccins « non-core », dont l'indication dépend du risque épidémiologique individuel. Le vaccin antirabique occupe, dans le contexte du mouvement international, une position particulière qui transcende cette classification : c'est une exigence de santé publique ayant une base légale dans la plupart des destinations, indépendamment du risque épidémiologique individuel de l'animal.

2.3 Échec vaccinal primaire

L'échec vaccinal primaire est l'absence de réponse immunologique adéquate après une vaccination correctement exécutée. Ses causes les plus fréquentes en pratique clinique comprennent :

- Interférence des anticorps maternels : chez les chiots et chatons, les anticorps transférés par la mère via le colostrum peuvent neutraliser les antigènes vaccinaux avant que le système immunitaire du jeune puisse les reconnaître et générer sa propre réponse. C'est le fondement des protocoles de vaccination en série chez les jeunes animaux.
- Immunosuppression concomitante : maladies débilitantes, traitements immunosuppresseurs ou infections actives au moment de la vaccination peuvent compromettre la réponse immunitaire résultante.
- Déficiences de la chaîne du froid : de nombreux vaccins sont thermolabiles. L'exposition à des températures inadéquates lors du transport ou du stockage peut dégrader les antigènes.
- Variabilité génétique individuelle : une petite proportion d'individus de toute espèce présente une capacité de réponse vaccinale réduite en raison de facteurs génétiques qui ne se manifestent cliniquement d'aucune autre manière.

L'échec vaccinal primaire est la raison pour laquelle l'épreuve de titration des anticorps --le RNATT-- existe comme exigence réglementaire dans certaines destinations : elle vérifie que la réponse immunologique s'est réellement produite, et pas seulement que l'acte de vaccination a été exécuté.

Section 3 Vaccination antirabique et santé publique

3.1 Justification épidémiologique

La rage est une encéphalite virale invariablement fatale chez les mammifères non vaccinés une fois la symptomatologie clinique établie. Son agent causal, le lyssavirus de la rage, a un spectre d'hôtes qui inclut pratiquement tous les mammifères domestiques et sauvages. La transmission survient principalement par la salive d'animaux infectés, par morsure ou contact avec les muqueuses ou les plaies ouvertes.

La pertinence de la rage dans le mouvement international des animaux de compagnie ne découle pas de sa prévalence dans les pays d'origine --nombre d'entre eux sont des pays dotés de programmes de lutte avancés ou au statut indemne de rage-- mais des conséquences qu'aurait l'introduction du virus dans des territoires actuellement indemnes. Les pays insulaires tels que le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Irlande ont historiquement maintenu le statut indemne de rage grâce à des contrôles d'importation stricts. La perte de ce statut aurait des conséquences sanitaires et économiques de grande ampleur.

3.2 La période minimale post-vaccinale : base immunologique du délai de 21 jours

La réglementation de l'Union européenne, telle que définie dans le Règlement (UE) n.º 576/2013, établit que la vaccination antirabique n'est pas valable pour le mouvement international tant que 21 jours ne se sont pas écoulés depuis l'administration de la première dose chez un animal non vacciné au préalable. Ce délai n'est ni arbitraire ni purement bureaucratique. Il repose directement sur la cinétique de la réponse immune humorale.

Après l'administration d'un vaccin antirabique à un animal sans antécédent de vaccination, les anticorps neutralisants commencent à être détectables environ entre les jours 7 et 14 post-vaccination chez la plupart des animaux, et atteignent des niveaux considérés protecteurs dans la plage de 21 à 28 jours. Le délai de 21 jours établit le point à partir duquel la probabilité qu'un animal ait généré une réponse immunologique adéquate est suffisamment élevée pour les besoins du contrôle du mouvement au niveau populationnel.

Il est important de comprendre que le délai de 21 jours est un critère de contrôle populationnel, et non une garantie de protection individuelle.

3.3 Revaccinations : la période de grâce et ses implications

Pour les animaux ayant un historique de vaccination antirabique antérieur et valide, la revaccination dans la période de validité du vaccin précédent ne redémarre pas le délai d'attente de 21 jours. La réponse anamnétique est suffisamment rapide pour considérer l'animal protégé immédiatement après la revaccination, ce que le Règlement (UE) 576/2013 reconnaît explicitement.

Cependant, si la revaccination est effectuée après l'expiration du vaccin précédent, la plupart des réglementations internationales traitent cet acte comme une première vaccination, avec le délai d'attente conséquent de 21 jours. La vérification de ce point est l'une des sources d'erreur les plus fréquentes dans la planification des voyages internationaux avec des animaux.

3.4 Le RNATT : épreuve de titration des anticorps antirabiques

Le rabies Neutralising Antibody Titre Test (RNATT) est une épreuve sérologique qui quantifie la concentration d'anticorps neutralisants contre le virus de la rage dans le sérum sanguin. Le seuil de référence international, établi par l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et adopté par les principales destinations qui l'exigent, est de 0,5 UI/mL.

Le RNATT ne mesure pas l'immunité au sens large --il n'évalue pas la réponse cellulaire, ni la mémoire immunologique à longue durée de vie--. Il mesure spécifiquement

la concentration d'anticorps neutralisants circulants au moment du prélèvement. Le seuil de 0,5 UI/mL a été établi comme valeur de coupure de référence sur la base d'études de corrélation entre les titres sérologiques et la protection dans des modèles expérimentaux de défi.

Des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Royaume-Uni et d'autres destinations au statut indemne de rage exigent le RNATT dans le cadre du protocole d'importation. La séquence : le RNATT doit être réalisé dans un laboratoire accrédité par l'OIE, à partir d'un échantillon prélevé au minimum 30 jours après la vaccination antirabique valide, et le résultat doit respecter le seuil de 0,5 UI/mL. Un résultat inférieur au seuil oblige à revacciner et à répéter l'épreuve.

Distinction clé : vaccination vs. épreuve sérologique
Certificat de vaccination antirabique : documente que l'acte de vaccination a été exécuté. Vérifie l'événement clinique, et non le résultat immunologique.
RNATT $\geq$ 0,5 UI/mL : documente que le système immunitaire de l'animal a répondu à la vaccination en générant des anticorps neutralisants à un niveau suffisant. Vérifie le résultat immunologique, et non l'acte clinique.
Les deux documents sont nécessaires dans les destinations qui exigent le RNATT. Aucun ne se substitue à l'autre.

Section 4 Identification et séquence correcte

4.1 La puce comme prérequis documentaire

La relation entre la puce et la vaccination dans le contexte du mouvement international n'est pas une simple coexistence : c'est une dépendance séquentielle. La puce doit être implantée et son numéro vérifié avant que le vaccin antirabique destiné à être enregistré dans la documentation d'exportation soit administré. Cette séquence n'est pas une convention ; elle repose sur la logique de la traçabilité.

Si le vaccin est administré avant l'implantation de la puce, une question techniquement insoluble se pose : comment peut-on établir que l'animal porteur de la puce

implantée ultérieurement est le même individu auquel le vaccin a été administré précédemment ? La plupart des réglementations internationales --y compris le Reglamento (UE) n.º 576/2013 et les exigences du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande-- considèrent invalide à des fins d'importation la vaccination effectuée avant l'implantation de la puce.

4.2 Traçabilité : le numéro qui relie tout

Le numéro de puce ISO à 15 chiffres est l'identifiant central de toute la chaîne documentaire de l'animal en transit international. Ce numéro doit figurer de manière exacte et identique dans chaque document : certificat de vaccination, résultats du RNATT le cas échéant, certificat de santé ou passeport européen, certificats de traitements antiparasitaires, et tout autre document de destination.

Une seule discordance dans le numéro peut invalider l'ensemble de la chaîne documentaire. La vérification du numéro par lecture directe de la puce, comparée à celui enregistré dans le système et à celui imprimé sur la documentation, est une étape de contrôle qui ne devrait pas être omise.

4.3 Conséquences documentaires de la séquence incorrecte

L'erreur de séquence --vaccination avant la puce-- est l'une des rares erreurs du processus d'exportation qui soit techniquement irréversible à court terme. Elle ne peut être corrigée ni par une déclaration rétroactive ni par une nouvelle vaccination simultanée à l'implantation de la puce. L'animal doit recevoir la puce et reprendre le protocole de vaccination, avec le délai d'attente de 21 jours, et dans les destinations exigeant le RNATT compléter l'épreuve sérologique. Selon la destination, le retard total peut être de plusieurs mois.

Section 5 Validité biologique vs. validité légale

5.1 Durée immunologique réelle vs. durée reconnue par la réglementation

La durée de l'immunité conférée par un vaccin est une variable biologique. La durée de la validité légale, en revanche, est une décision réglementaire. Ces deux durées ne coïncident pas toujours. Dans le cas du vaccin antirabique, les vaccins modernes ont démontré des durées d'immunité pouvant dépasser trois ans chez les chiens correctement vaccinés. Cependant, de nombreuses juridictions maintiennent des cycles de revaccination annuels ou bisannuels pour des raisons qui combinent le principe de précaution et la fonction sociale de la visite vétérinaire annuelle.

Dans le contexte du mouvement international, la validité légale du certificat de vaccination prévaut toujours sur l'évaluation immunologique individuelle.

5.2 La différence entre gestion populationnelle et immunité individuelle

Les systèmes de contrôle sanitaire sont conçus pour gérer le risque au niveau populationnel. L'objectif n'est pas de garantir que chaque animal individuel soit immun, mais de maintenir la probabilité d'introduction de pathogènes dans une population réceptrice en dessous d'un seuil acceptable. Un animal ayant satisfait à toutes les exigences réglementaires n'est pas, par définition, exempt de risque biologique individuel. Il peut avoir connu un échec vaccinal primaire non détecté ou être en période d'incubation d'une maladie acquise juste avant le voyage.

5.3 Différences réglementaires entre destinations

La durée de validité reconnue pour le certificat de vaccination antirabique varie selon les juridictions. Un certificat à validité reconnue dans le pays d'origine peut avoir une validité différente --ou être expiré-- selon la réglementation du pays de destination. Le calcul de la validité doit toujours être effectué selon les critères de la destination, et non ceux de l'origine.

Section 6 Formats et cadre réglementaire par pays

Avertissement de mise à jour réglementaire -- Section 6 Les informations de cette section décrivent le type de cadre réglementaire de chaque juridiction, et non les exigences spécifiques en vigueur. Les réglementations évoluent fréquemment. Les formats officiels, les délais exacts, les laboratoires accrédités et les procédures de validation peuvent être modifiés sans préavis. La vérification directe et à jour auprès de l'autorité sanitaire compétente du pays de destination et de transit est obligatoire avant d'émettre tout certificat. Cet article ne se substitue pas à ce processus.

6.1 Union européenne -- Cadre d'harmonisation supranationale

L'Union européenne dispose du système de mouvement des animaux de compagnie le plus harmonisé au monde. Le Règlement (UE) n.º 576/2013 établit un cadre uniforme applicable aux 27 États membres. Document de référence : le Passeport Européen pour Animal de Compagnie, délivré par des vétérinaires habilités. Comprend l'identification (puce), la vaccination antirabique valide, les traitements antiparasitaires lorsque requis. La période minimale post-première vaccination antirabique est de 21 jours.

Pour le mouvement depuis des pays tiers vers l'UE : un certificat sanitaire officiel est exigé selon les modèles établis dans les règlements d'exécution applicables, émis par le vétérinaire officiel du pays d'origine. La vérification du modèle en vigueur incombe au vétérinaire émetteur.

6.2 Royaume-Uni -- Certification post-Brexit

Le document de référence pour l'entrée au Royaume-Uni depuis l'étranger est l'Animal Health Certificate (AHC), émis par un vétérinaire officiel agréé au maximum 10 jours avant le voyage. L'AHC n'est pas réutilisable : chaque voyage requiert un nouveau certificat. Puce ISO 11784/11785 obligatoire. La vérification du modèle en vigueur sur GOV.UK est obligatoire avant émission.

6.3 Australie -- DAFF

L'Australie applique l'un des protocoles de biosécurité les plus stricts au monde. Elle exige la vaccination antirabique, le RNATT $\geq 0,5$ UI/mL dans un laboratoire accrédité, le délai d'attente post-RNATT, des traitements antiparasitaires spécifiques et une quarantaine obligatoire à l'arrivée. Séquence : puce avant vaccination antirabique ; vaccination avant le RNATT, avec minimum 30 jours entre vaccination et prélèvement pour le RNATT. Vérification sur agriculture.gov.au avant émission obligatoire.

6.4 Nouvelle-Zélande -- MPI New Zealand

La Nouvelle-Zélande applique la norme CATDOG.GEN, l'un des protocoles les plus exigeants au monde. Séquence : puce → vaccination antirabique → RNATT → délai d'attente post-RNATT → traitements → certification → quarantaine obligatoire. Particularité : la puce doit être implantée avant le prélèvement pour le RNATT, et pas seulement avant la vaccination. Vérification sur mpi.govt.nz avant émission obligatoire.

6.5 Autres destinations -- Principe de vérification obligatoire

Pour toutes les destinations non détaillées, la vérification auprès de l'autorité sanitaire compétente du pays de destination est obligatoire. Le principe opérationnel universel :

Le message central est que l'interprétation réglementaire correcte et la vérification officielle en vigueur au moment de l'émission sont la seule garantie raisonnable de conformité documentaire.

Section 7 Erreurs techniques qui compromettent la validité du certificat

7.1 Incohérence puce-certificat

La discordance entre le numéro de puce lu sur l'animal et celui enregistré dans les documents est l'erreur ayant le plus fort impact. Variantes fréquentes : numéro transcrit avec erreur typographique ; numéro enregistré à partir de l'emballage de la puce sans vérification post-implantation ; numéro d'une ancienne puce avec une seconde puce implantée sans mise à jour des documents ; numéro différent dans différents documents du

même dossier.

7.2 Dates incompatibles avec les périodes minimales

Les incompatibilités les plus fréquentes : date de vaccination antirabique postérieure à la date d'émission du certificat sanitaire ; date de prélèvement pour le RNATT antérieure à 30 jours post-vaccination ; certificat émis en dehors de la fenêtre temporelle exigée ; vaccin antirabique avec date antérieure à l'implantation de la puce.

7.3 Vaccins non autorisés en destination

Tous les vaccins disponibles dans le pays d'origine ne sont pas autorisés ou reconnus dans le pays de destination. La vérification que le vaccin administré figure sur la liste des vaccins reconnus par la destination est une étape préalable au choix du vaccin.

7.4 Absence de signature, cachet ou numéro d'habilitation

De nombreuses destinations exigent la signature d'un vétérinaire disposant d'une habilitation officielle spécifique, d'un numéro d'inscription ordinale, d'un numéro d'habilitation et du cachet de l'établissement. L'absence de l'un de ces éléments peut être cause de rejet formel.

7.5 Enregistrement incomplet du lot et du fabricant

Certaines destinations exigent l'enregistrement du numéro de lot et du fabricant sur le certificat. Son omission, lorsqu'elle est requise, est cause d'invalidation. L'enregistrement au moment de la vaccination --et non ultérieurement-- en garantit la disponibilité et l'exactitude.

Section 8 Limites des preuves

8.1 Le certificat ne garantit pas une immunité individuelle absolue

La validité documentaire du certificat et la protection immunologique individuelle sont deux variables liées mais non équivalentes. Un certificat formellement correct atteste que les actes médico-documentaires requis ont été exécutés. Il n'atteste pas que le système immunitaire a répondu de manière optimale ni que la chaîne du froid a été parfaite. Ce n'est pas le dévaloriser en tant que garantie individuelle absolue, ce qui n'a jamais été sa fonction.

8.2 Absence d'études sur l'impact du transport sur la réponse vaccinale

Il n'existe aucune étude publiée ayant évalué si le stress du transport aérien a un impact mesurable sur les titres d'anticorps vaccinaux chez le chien ou le chat dans la période post-voyage immédiate. En l'absence de cette preuve, il n'est pas possible d'affirmer que le transport compromet la réponse vaccinale, ni qu'il ne le fait pas.

8.3 La réglementation comme instrument de gestion du risque collectif

Les exigences réglementaires sont des instruments de politique sanitaire, et non des protocoles cliniques individualisés. Le vétérinaire qui travaille en médecine des voyages opère à l'intersection entre la biologie individuelle de son patient et le cadre réglementaire collectif.

Section 9 Synthèse finale

Le certificat de vaccination pour le mouvement international est la traduction administrative d'un événement immunologique complexe. Sa validité résulte de l'alignement précis de trois dimensions qui doivent être respectées simultanément :

La dimension clinique : l'acte de vaccination doit avoir été exécuté correctement, avec le vaccin approprié, dans les conditions techniques requises. La signature du vétérinaire déclare que cette dimension a été respectée.

La dimension identité : l'animal doit être non équivoquement identifié avant la vaccination par puce ISO, et cet identifiant doit être enregistré avec exactitude dans tous les

documents du dossier sanitaire.

La dimension réglementaire : le format, les délais, les contenus exigés et les signatures autorisées doivent correspondre à ce qu'établit la réglementation en vigueur du pays de destination au moment exact de l'émission.

Lorsque ces trois dimensions sont alignées, le certificat remplit sa fonction. Lorsque l'une échoue --par erreur clinique, défaut d'identification ou déviation réglementaire-- le document perd cette capacité d'attestation. Cette interdépendance fait du certificat de vaccination international un acte médico-documentaire complexe.

References

- Unión Europea. Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013. Diario Oficial de la Unión Europea, L 178, 1-26.
- United Kingdom Government. The Microchipping of Dogs (England) Regulations 2015. SI 2015/108.
- United Kingdom Government. The Microchipping of Cats and Dogs (England) Regulations 2023.
- Australian Government. DAFF. Importing cats and dogs.
<https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs>
- New Zealand Government. MPI. Importing dogs and cats (CATDOG.GEN).
<https://www.mpi.govt.nz/importing/animals/importing-dogs-and-cats/>
- GOV.UK -- DEFRA/APHA. Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain.
<https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain>
- WOAH/OIE. Terrestrial Animal Health Code. Chapter on Rabies. <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>
- WSAVA. Guidelines for the Vaccination of Dogs and Cats (2016). Journal of Small Animal Practice, 57(1), E1-E45.
- Day, M. J., et al. (2016). WSAVA Guidelines for the vaccination of dogs and cats. JSAP, 57(1), E1-E45. https://doi.org/10.1111/jsap.2_12431
- Schultz, R. D., et al. (2010). Age and long-term protective immunity in dogs and cats. J Comp Pathol, 142(Suppl 1), S102-S108. <https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2009.10.009>
- Tizard, I. R. (2022). Veterinary Immunology (11th ed.). Elsevier.
- WHO. Rabies -- Key facts. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>
- Rupprecht, C. E., et al. (2017). Rabies vaccines and post-exposure prophylaxis. In Plotkin's Vaccines (7th ed.). Elsevier.
- Cliquet, F., et al. (1998). Development of a fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVN test). J Immunol Methods, 212(1), 79-87.
[https://doi.org/10.1016/S0022-1759\(97\)00212-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1759(97)00212-3)

Figure 1. Decision flowchart — certificate validity for international pet movement.

Sequential AND-logic: every condition must hold; any single failure invalidates the whole documentary chain. Adapted from EU Reg. 576/2013

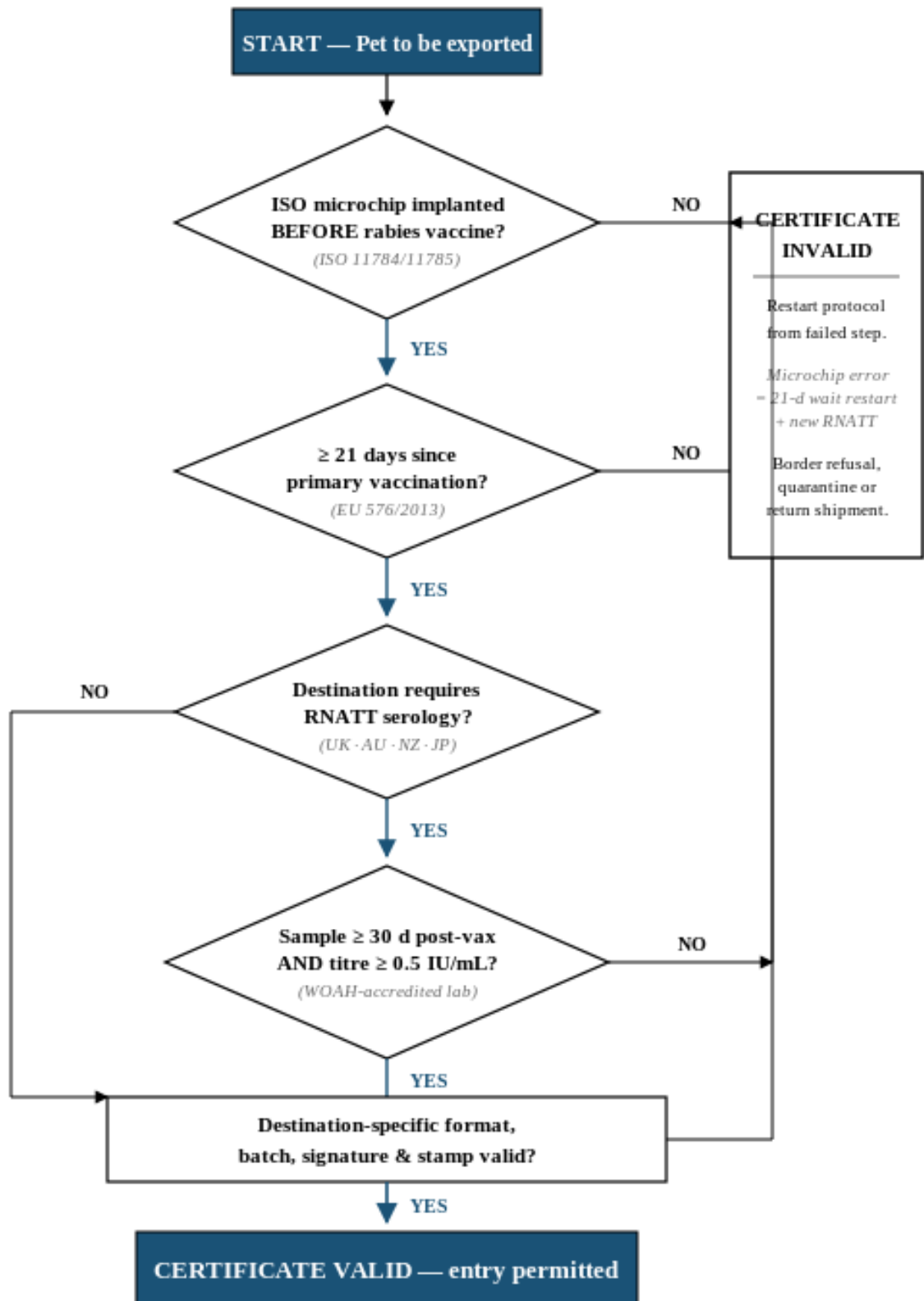


Figure 2. Comparative matrix — certificate validity windows by destination.

Synthesis of EU Reg. 576/2013, UK APHA AHC scheme, AU DAFF, NZ MPI CATDOG.GEN. Subject to regulatory updates — direct verification with competent authority is mandatory before emis.

Requirement	European Union <i>Reg. 576/2013</i>	United Kingdom <i>APHA — AHC</i>	Australia <i>DAFF</i>	New Zealand <i>MPI · CATDOG.GEN</i>	Other 3rd countries <i>verify per destination</i>
ISO microchip sequence <i>11784/11785</i>	Before vaccine <i>mandatory</i>	Before vaccine <i>mandatory</i>	Before vaccine <i>mandatory</i>	Before RNATT <i>stricter rule</i>	Per destination
Primary-vax wait <i>days post-injection</i>	≥ 21 d	≥ 21 d	≥ 21 d	≥ 21 d	Per destination
RNATT serology <i>≥ 0.5 IU/mL (FAVN/RFFIT)</i>	Non-listed 3rd countries only	Required for most 3rd countries	Required <i>sample ≥ 30 d post-vax</i>	Required <i>sample ≥ 30 d post-vax</i>	Variable
Post-titre waiting period <i>sample date → entry</i>	3 months <i>non-listed origin</i>	3 months <i>most 3rd countries</i>	≥ 180 d <i>after 2nd titre</i>	≥ 180 d <i>strictest globally</i>	Variable
Certificate emission window <i>issue → travel</i>	EU Pet Passport <i>reusable, lifetime</i>	AHC ≤ 10 d <i>single use only</i>	Import permit <i>per consignment</i>	Import permit <i>per consignment</i>	Per destination
Arrival quarantine <i>if compliant</i>	None <i>on full compliance</i>	None <i>on full compliance</i>	Mandatory <i>PAQS facility</i>	Mandatory <i>MPI facility</i>	Variable
Minimum total protocol <i>vaccine → arrival</i>	~ 4 months	~ 4 months	~ 7–9 months	~ 7–9 months	Variable

■ High-stringency value / strictest case

Acronyms: RNATT — rabies neutralising antibody titre test; FAVN — fluorescent antibody virus neutralisation; AHC

Note: validity windows must be calculated against destination criteria, never origin. Direct verification with the competent authority is mandatory before each emission.

© Jessica Y. Camacho García, MVZ — CMVP 12434 | Zoovet Travel Technical Series Vol. IX | zoovettravel.com | 2026

ISO 11784:1996. Radio Frequency Identification of Animals -- Code Structure.

ISO 11785:1996. Radio Frequency Identification of Animals -- Technical Concept.

Outil pratique

Votre animal peut-il voyager à votre date exacte ?

Calculez en temps réel : FAVN, micropuce, vaccin, quarantaine et exigences de 22 pays.

Feu rouge/orange/vert + calendrier inversé + PDF.